RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**INTUBASI PADA PASIEN TBC (Tuberkolusis Paru)**		
	No.Dokumen 400.7.3.4 / 1241 / 2026	No.Revisi 02	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Intubasi Pasien TBC adalah memasukkan pipa udara napas buatan ke dalam trachea melalui mulit atau hidung pada pasien TBC
TUJUAN	1. Membebaskan jalan napas 2. Untuk pemberian napas mekanik (dengan ventilator)
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	**Standar Alat :** a. Trolley emergency b. Laringoscope c. Peralatan section d. Spuit 5 cc e. Sarung tangan f. Plester atau hipafix g. Gunting verban h. Batal /penyangga i. Bag Mask valve j. Ventilator kalau perlu k. OPA (oro pharingeal Airway) l. ETT (Endo thracheal Tube) sesuai ukuran

m. Jelly

n. Stetoskop

o. Obat anstesi (Rokuron)

Standar APD untuk petugas

1. Masker N95
2. Helm apd
3. Kacamata goggle
4. Sepatu boot
5. Baju ganti
6. Baju pelindung APD
7. Sarung tangan panjang steril

Standar Pasien :

a. Inform consent

b. Pasien posisi tidur terlentang

Prosedur:

1. Petugas cuci tangan lalu pakai APD lengkap sebelum masuk Isolasi
2. Troley emergemcy di dorong mendekat ke sisi tempat tidur.
3. Pasang monitor EKG untuk memonitor gambaran EKG selama pemasangan ETT agar segera dapat mengatasi bila terjadi gangguan irama jantung
4. Cek alat alat yang di perlukan dan pilih ukuran ETT sesuai kebutuhan.
5. Beri jelly / pelumas pada ujung ETT sampai daerah cuff
6. Berikan sedasi sesuai advis dokter

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**INTUBASI PADA PASIEN TBC (Tuberkolusis Paru)**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1241/2026	No.Revisi 02	Halaman : 3/4

7. Lakukan hiperventilasi dengan BMV minimal 30 detik
8. Letakkan bantal atau penyangga pada oksiput setinggi 10 cm dan kepala tetap ekstensi.
9. Bila perlu lakukan penghisapan lendir.
10. Buka mulut dengan croos finger dan tangan kiri memegang laringoscope
11. Masukkan blade laringoscope menelusuri mulut sebelah kanan , sisihkan lidah ke kiri ,masukkan blade sampai dasar lidah , perhatikan agar lidah / bibir tidak terjepit di antara blade dan gigi pasien
12. Angkat laringoscope ke atas dan ke depan dengan kemiringan 30-45 derajat , jangan menggunakan gigi sebagai tumpuan
13. .Bila pita suara sudah terlihat lakukan sellick manuever masukkan ETT sambil memperhatikan bagian proximal cuff ETT melewati pita suara antara 1-2 cm atau pada kedalaman ETT 19-23 cm
14. Waktu untuk intubasi tidak boleh lebih dari 30 detik . Lakukan ventilasi dengan menggunakan bagging dan lakukan auskultasi , pertama pada lambung kemudian ke paru kanan dan kiri sambil memperhatikan perkembangan dada
15. Bila terdengar suara gurgling pada lambung dan dada tidak mengembang paru lepaskan ETT dan lakukan hyperventilasi lagi selama 30 detik dan 02100 % selanjutnya lakukan intubasi kembali
16. Bila di lambung tidak terdengar gurgling dan kedua paru mengembang serta suara paru kanan dan kiri sama berarti pemasangan ETT sudah benar
17. Kembangkan balon cuff dengan menggunakan spuit 5

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**INTUBASI PADA PASIEN TBC (Tuberkolusis Paru)**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1241/2026	No.Revisi 02	Halaman : 4/4
	cc dengan volume secukupnya sampai tidak terdengar suara kebocoran udara di mulut saat ventilasi 18. Lakukan fiksasi ETT dengan plester agar tidak terdorong atau tercabut 19. Lakukan ventilasi terus dengan 02 100 % kemudian bila sambungkan dengan ventilator 20. Seting mode Ventilator sesuai kondisi pasien 21. Rapikan alat dan pasien 22. Setelah selesai tindakan petugas ke luar dari ruang Isolasi 23. Lepas APD masukan ke tempat platik infeksius 24. Cuci tangan		
UNIT TERKAIT	Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensive IGD Ruang isolasi TBC		